

基礎研 レポート

臨時国会で成立した改正医療法 で何が変わるのか(下)

医師偏在対策を強化、電子カルテやオンライン診療の拡大策などを規定

保険研究部 ヘルスケアリサーチセンター 上席研究員 三原 岳
(03)3512-1798 mihara@nli-research.co.jp

1——はじめに～医師偏在対策など、臨時国会で成立した改正医療法で何が変わるのか～

2025 年臨時国会では、医療提供体制改革に関わる改正医療法が与党などの賛成多数で可決、成立した。今回の法改正では、2025 年に期限を迎えた「地域医療構想」の目標を 2040 年に延長するとともに、医師偏在是正対策の強化などの医療提供体制改革に関わる項目が数多く盛り込まれた。さらに、オンライン診療など医療 DX (デジタルトランスフォーメーション) の推進に関する改正も実施された。

このうち、新たな地域医療構想と医師偏在是正対策については、2026 年に各都道府県で検討してもらい、2027 年度以降に具体的な協議が各地で進められることが想定されている。

全 3 回シリーズの [\(上\)](#) [\(中\)](#) では新たな地域医療構想に着目し、外来や在宅など幅広い分野を網羅する側面が強まった点、「病床削減を目的としないと言いつつ、病床数で進捗が語られる」という構造的な分かりにくさが解消された点、多面的かつ複雑な利害調整など都道府県での運用が一層、重要になる可能性などを指摘した。

(下) では医師偏在是正や医療 DX に関わる改正内容を概観する。このうち、医師偏在では重点的に資源や人材を集中させる仕組みが作られた点に触れる。その後、今回の対策が「開業の自由」を認めつつ、対策を強化する「苦肉の策」が取られている点を強調しつつ、医師偏在を劇的に改善するほどの効果は期待できない点を述べる。

さらに、オンライン診療の活用や医療・介護を必要とする高齢者が集まって住む「集住」の選択肢など、都道府県に総合的な対策を講じる必要性を指摘する。医療 DX ではオンライン診療や電子カルテの拡大、レセプト (支払明細書) をチェックする社会保険診療報酬支払基金の大幅改組などに関わる規定を取り上げる。

2——改正医療法の概要

[\(上\)](#) でも述べた通り、改正医療法に関して、厚生労働省が公表した概要資料は図表 1 の通りである。ここでは「地域医療構想の見直し等」「医師偏在是正に向けた総合的な対策」「医療 DX の推進」という 3 つの項目に整理されており、施行期日は 2027 年 4 月 (一部は異なる)。既に厚生労働省は 2025 年 7 月から「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(以下、地域医療構想検討会) を設置し、

都道府県向けガイドラインの検討に着手しており、都道府県における新たな地域医療構想や医師偏在是正対策の検討は2026年度、これを基にした協議は2027年度から段階的に進められることが想定されている。さらに、今回のテーマである医師偏在是正のうち、新規開業における新たなルールは2026年10月から始動することが予定されている。

以下、社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）医療部会が2024年12月に取りまとめた「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」（以下、総合的な改革意見）や、その前段として策定された「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」（以下、対策パッケージ）など、2024年11～12月にまとまった厚生労働省の検討組織の報告書などをベースにしつつ、「医師偏在対策の強化」「医療DXの推進」という2点について、それぞれの経緯や論点を詳述する。その際には必要に応じて、改正医療法における国会答弁や厚生労働省の検討組織における議論などにも言及する¹。

図表1：2025年臨時国会で成立した改正医療法等の主な内容

医療法等の一部を改正する法律案の概要	
改正の趣旨	高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。
改正の概要	1. 地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】 ① 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。 ・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。 ・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。 ・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。 ② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。 ③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。 2. 医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】 ① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。 保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。 ② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。 ③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課することとする。 3. 医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】 ① 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。 ② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの匿名化情報の利用・提供を可能とする。 ③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。 また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。 このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。
施行期日	令和9年4月1日（ただし、一部の規定は令和8年4月1日（1②並びに2①の一部、②及び③）、令和8年10月1日（1①の一部）、公布後1年以内に政令で定める日（3①の一部）、公布後1年6月以内に政令で定める日（3③の一部）、公布後2年以内に政令で定める日（1③及び3③の一部）、公布後3年以内に政令で定める日（2①の一部並びに3①の一部及び3②）等）

出典：厚生労働省資料から抜粋

3——法改正に至った医師偏在対策を巡る経緯

1 | 医師確保計画と外来医療計画

現在の医師偏在是正対策に至る淵源は2006年の新臨床研修制度に遡る²。この時、特定の専門領域

¹ 煩雑さを避けるため、発言などを除き、可能な限り引用や出典は省略するが、本稿執筆に際しては、内閣府や厚生労働省などのウェブサイト参照。メディアでも『朝日新聞』『共同通信』『産経新聞』『東京新聞』『日本経済新聞』『毎日新聞』『読売新聞』に加えて、『社会保険旬報』『週刊社会保障』『国保実務』『m3.com』『Gem Med』などの記事も参考にした。

² 医師偏在対策のうち、対策パッケージに至る過程については、2024年11月11日拙稿「医師の偏在是正はどこまで可能か」、医師確保計画と外来医療計画が始まった頃の議論については、2020年2月17日拙稿「[医師偏在是正に向けた2つの計](#)

に限らず、幅広い分野の専門研修を義務付けるとともに、希望に基づいて研修医と研修病院を調整するマッチングシステムが導入された。この結果、多くの研修医が都市部の病院を選ぶようになった。

一方、大学病院サイドも研修体制の充実が求められるようになり、大学から地域の病院に派遣していた医師を引き揚げたため、残された医師の職場環境が悪化。負担増を避けるために開業したり、病院を辞めたりする医師が続出し、残された勤務医の負担が増える悪循環が生まれた。その結果、一部の地域では産科医などを受診できない「医療崩壊」が社会問題になった³。

そこで、2006年8月に「新医師確保総合対策」が決定され、医師数が少ない青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重の各県を対象に、大学医学部の定員を臨時的に増やした。

最近の大きな制度改正として、2018年通常国会で成立した改正医療法がある。この時には医師偏在を是正するため、「医師確保計画」「外来医療計画」を都道府県に作成してもらうことに力点が置かれた。その後、各都道府県は6年サイクルの「医療計画」の一部として、2つの計画を2020年3月までに作成した。

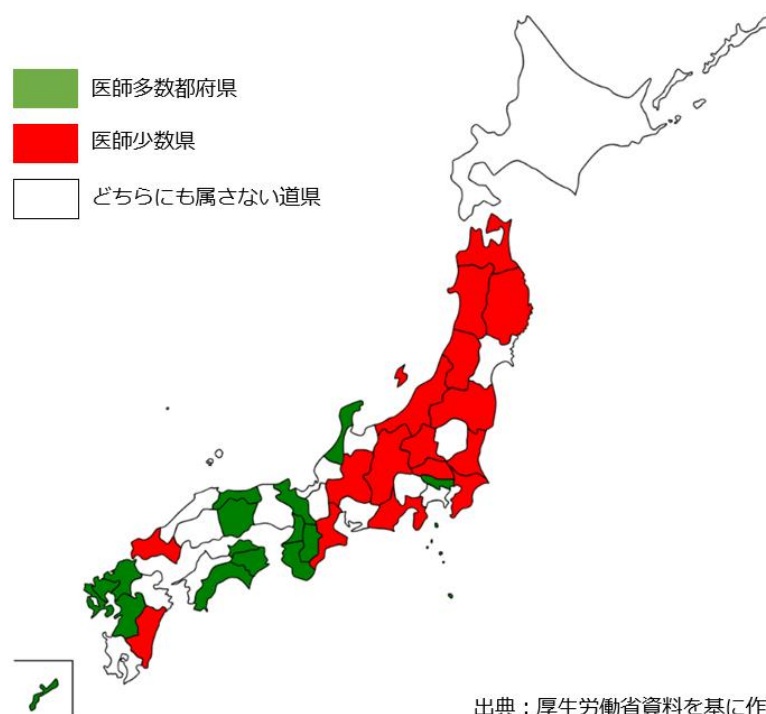
このうち、医師確保計画に関しては、医師の過不足を全国一律の水準で可視化する「医師偏在指標」が導入された。この指標を通じて、地域ごとの医療ニーズや人口構成、医師の年齢構成などを反映させつつ、医師の多寡が都道府県別だけでなく、人口20～30万人単位で区切られる2次医療圏で明らかになった。

その上で、上位3分の1の都道府県を「医師多数都道府県」、下位3分の1を「医師少数都道府県」、どちらにも属さない都道府県の3つに分類し、2036年までに医師少数とされた県が下位3分の1を脱却するまで指標を改善することが目標とされている。

2024年度からスタートした医療計画における医師偏在指標に基づく都道府県の分類は図表2の通りである。

さらに、2次医療圏単位でも、同じように医師偏在指標

図表2：医師偏在指標に基づく医師偏在の状況



出典：厚生労働省資料を基に作成

に基づいて、「医師多数区域」「医師少数区域」「どちらにも属さない区域」の3つに分類された。その上で、奨学金の返済を免除する代わりに地方勤務を義務付ける「地域枠」の設定を通じて、できるだけ若手医師が医師少数区域で働いてもらうために必要な施策が医師確保計画に盛り込まれている。

[画はどこまで有効か](#)（全2回、リンク先は第1回）を参照。

³ 当時、「立ち去り型サボタージュ医療崩壊」と呼ばれた。小松秀樹（2006）『医療崩壊』朝日新聞社などを参照。

もう一つの外来医療計画の関係では、外来医師の偏在を示す「外来医師偏在指標」がスタートし、上位3分の1が「外来医師多数区域」と設定されるなど、外来医師の過不足が可視化された。

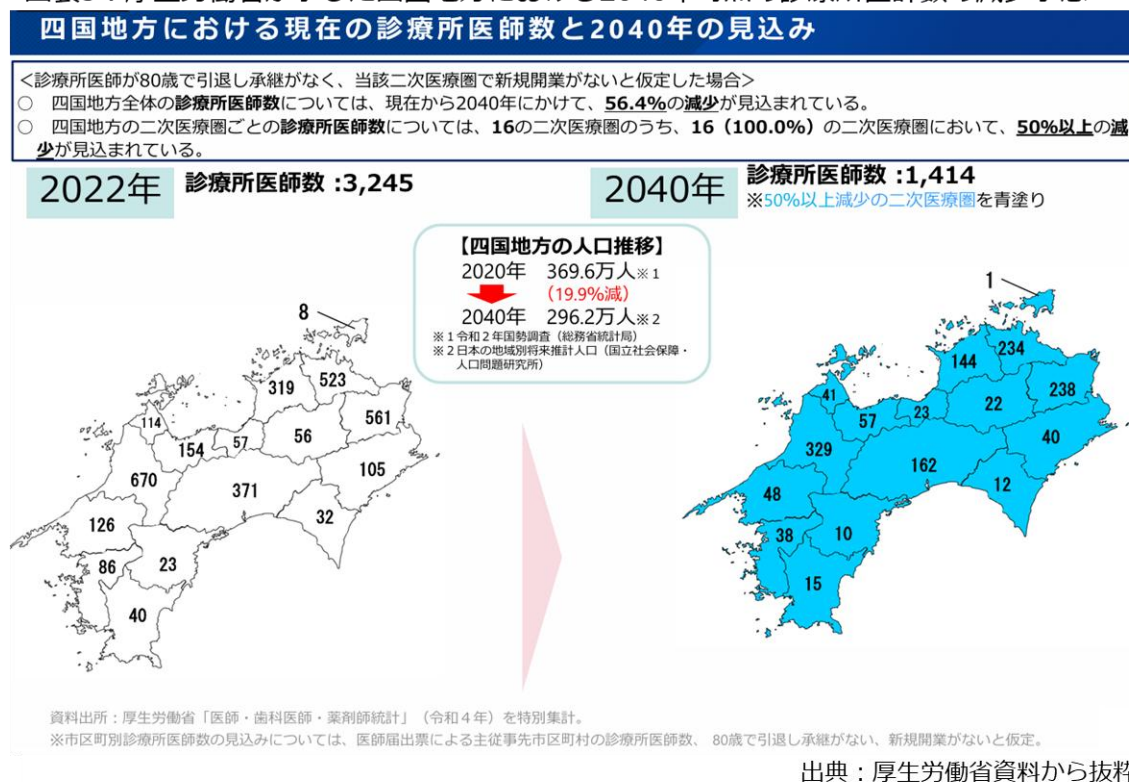
その上で、外来医師多数区域で新規に開業を希望する場合、「医療提供体制改革を議論する協議の場への参加要請→席上、在宅医療など地域で不足している機能を担うことを要請→新規開業者の自主的な対応に期待→必要に応じて協議結果を住民などに公表」という流れが想定されており、2024年度現在の集計によると、これまで合意に至った件数（複数回答）は学校医など公衆衛生で451件、在宅医療で226件、夜間・休日の初期救急で206件などとなっている。

2 | 既存の施策の限界

しかし、医師偏在指標を見ると、全体として偏在が進んだ⁴。このため、独自の助成制度で開業医を誘致する市町村が増え始めている⁵。

それだけ地域の医師不足が深刻になっており、こうした状況は開業医の高齢化に伴って一層、進む可能性が高い。例えば、厚生労働省の推計では診療所が存在しない市町村の数は2022年時点で77であるのに対し、2040年には342に増えるという。

図表3：厚生労働省が示した四国地方における2040年時点の診療所医師数の減少予想



今回の検討に際して、注目を集めたのは2040年時点における診療所医師数の激減予想である。これは2024年11月、厚生労働省が検討組織に提出した資料であり、何も対策を実施しない場合、どれだ

⁴ 医師偏在指標では医療の需要などに加えて、医師の年齢も考慮することになっており、何も対策を実施しない場合、開業医が高齢化すると、指標の数字は悪化する。

⁵ 例えば、開業医を誘致するため、山形県米沢市は最大1,000万円、長野県辰野町と鳥取県智頭町は最大5,000万円、鹿児島県志布志市は最大1億円を支援する制度を始めている。自治体の動きについては、それぞれの市町村のウェブサイトに加えて、『朝日新聞』『毎日新聞』『新潟日報』『信濃毎日新聞』『南日本新聞』『m3.com』を参照。

け診療所の医師が2040年時点で減るのか、ブロックごとに試算の結果が示された。しかも、この資料では、それぞれのブロックで診療所の医師が半分以上、減る2次医療圏が青色で塗られており、一例として図表3で挙げた四国ブロックでは、相対的に病院や病床、医師の数が多い高知県も含めて、全ての2次医療圏で診療所の医師が半分以上、減るという結果だった。

他のブロックでも同様の状況であり、図表4の通り、北海道では76.1%、東北は73.0%、中国は90.0%の2次医療圏で診療所の医師が半分以上、減るという予想が示された。

このほか、中長期的に見ると、2024年4月から始まった医師の残業規制（働き方改革）の影響も偏在に拍車を掛ける可能性がある⁶。従来であれば、超過勤務など労働投入量を増やす対応が取れたが、これが難しくなり、地域医療の現場における人手不足に拍車を掛ける可能性が高い。

このように偏在是正が思うように進まない根本的な原因として、日本の医療提供体制は民間中心であり、

かつ医師に開業の自由が広く保障されている点を指摘できる。つまり、公立病院の勤務医など一部を除き、国や自治体が医師に対し、医師の勤務先を強制的に指定することは不可能である。さらに、国や都道府県による強制的な割当に関しては、プロフェッショナル・オートノミー（専門職による自律性）を重視する日本医師会（以下、日医）の反対が根強い。

こうした状況では、医師の自由選択を貴ぶと、都市部に医師が集中しやすくなるため、偏在が進み、医師の行動を規制しようとする、開業の自由に抵触することになる。一言で評すると、自由と統制のトレードオフの下で発生している問題と言える。

実際、開業の自由との関係性は外来医療計画がスタートする時点でも話題になっており、日医が「開業するにはどの地域が適切かを“見える化”する」「強制力を持つものではなく、決して国の管理でも自由開業規制でもありません」と説明する一幕もあった⁷。それだけ関係者にとってセンシティブなテーマであり、言い換えると、開業の自由を前提とする限り、クリアカットな解決策は存在しない。

3 | 武見厚生労働相の発言で検討が加速

しかし、武見敬三厚生労働相（当時、以下の肩書は全て当時）が2024年4月のNHK番組で、「地域において医師の数の割り当て、これも本気で考えなきゃならない」と述べるなど、大胆な施策の必要

図表4：ブロック別に見た2040年時点における診療所医師の減少予想

ブロック名	診療所の医師数の減少率	診療所の医師が半分以上、減る2次医療圏の比率	【参考】診療所で勤務する医師の数（2022年度）	【参考】現在の2次医療圏の数
北海道	47.2%	76.1%	3,384人	21
東北	54.0%	73.0%	6,299人	37
関東	41.5%	34.3%	37,596人	70
中部	48.4%	66.7%	17,311人	57
近畿	48.2%	56.9%	19,659人	51
中国	53.2%	90.0%	6,831人	30
四国	56.4%	100.0%	3,245人	16
九州	49.3%	65.1%	13,093人	63

出典：厚生労働省資料を基に作成

⁶ 医師の働き方改革では、勤務医の残業時間を原則として年間960時間に抑える残業規制が導入された。その内容や影響については、2023年9月29日拙稿「[施行まで半年、医師の働き方改革は定着するのか](#)」を参照。

⁷ 2019年7月4日『m3.com』配信記事における今村聡副会長のコメントを参照。

性に言及したことで、複数の厚生労働省の検討組織で急ピッチに議論が進められた⁸。

具体的には、「医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」が2024年1月から検討を開始しており、医学部の臨時定員を地域枠に振り替える方向性などが武見氏の発言以前から議論されていた。さらに、社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）の医療部会と医療保険部会、同年3月から始動していた「新たな地域医療構想等に関する検討会」でも偏在対策が同時並行的に話し合われた。

結局、2024年12月に決まった対策パッケージでは図表5の通り、(1) 医師養成課程を通じた取組、(2) 医師確保計画の実効性の確保、(3) 地域偏在対策における経済的インセンティブ、(4) 地域の医療機関の支え合いの仕組み——という4つに整理された。

図表5：医師偏在是正に関する総合的なパッケージに盛り込まれた主な施策

1：医師養成課程を通じた取組	
➤	医学部臨時定員を削減しつつ、医師少数県に地域枠を充当など。
2：医師確保計画の実効性の確保	
➤	定住が見込まれるのに、医療機関の減少スピードが早い地域を対象に、都道府県が「重点医師偏在対策支援区域」を設定。都道府県が医師確保計画で「医師偏在是正プラン」を策定し、対策を強化。
3：地域偏在対策における経済的インセンティブなど	
➤	診療所の承継や開業、地域定着を支援、派遣医師や従事医師への手当増額、派遣元医療機関への支援。
➤	全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すための機会を提供。
➤	地域枠設定など都道府県と大学病院の連携パートナーシップの締結。
4：地域の医療機関の支え合いの仕組み	
➤	医師少数区域での勤務経験を管理者の要件とする対象医療機関として公的病院など追加、勤務経験期間を6カ月以上から1年に延長。
➤	外来医師過多区域での新規開業を希望する医師に対し、都道府県が不足する医療機能の提供を要請。要請に従わない場合、勧告や公表、保険医療機関の指定期間を6年から3年に短縮、診療報酬上の対応、補助金の不交付などを実施。
➤	保険医療機関に管理者要件を設け、2年の臨床研修と3年間の病院勤務を義務化。

出典：厚生労働省資料を基に作成

4 | 対策パッケージの内容

このうち、1 番目では全体として医学部臨時定員を削減しつつ、医師少数県の地域枠を拡充する方向性が提示されており、その後の厚生労働省の検討組織における議論では、地域枠を設定する場合、原則として恒久定員で対応する方向となった。

2 つ目では、都道府県の医師確保計画を2026年度から強化する方向性が示された。具体的には、都道府県が「医師確保計画」を改定する過程で、「重点医師偏在対策支援区域」（以下、支援区域）を設定するとともに、支援区域で施策を重点的に進める「医師偏在是正プラン」を作ることになっている。

3 つ目では、▽診療所の承継や開業、地域定着の支援、▽過疎地などで働く医師に対する手当増額、▽派遣元医療機関に対する支援、▽全国的なマッチング支援、▽中堅医師に対する総合的な診療能力を学び直すための機会の提供——などが列挙された。

⁸ 2024年4月7日放映のNHK番組における発言。同日配信の『朝日新聞デジタル』記事を参照。

4つ目では元々、「規制的な手法」という言葉が使われていたが、「医療機関の支え合い」という言葉に変更された。対策の内容としては、今までは医師少数区域での勤務経験を管理者の要件とする対象医療機関が「地域医療支援病院」⁹に限定されていたが、新たな対策では対象に公的病院などが追加されることになったほか、勤務経験期間も6カ月以上から1年に延長された。

さらに、近年は自由診療の美容整形にダイレクトに就職（いわゆる「直美」）する若手医師が散見され、医師の都市部集中を招いている面があるため、保険医療機関の管理者要件として、2年の臨床研修と3年間の病院勤務で保険診療に従事したことを義務付ける方向性も盛り込まれた。

その後、2026年1月の中央社会保険医療協議会（厚生労働相の諮問機関、中医協）に対する諮問を経て、これらに関する規定が整備された。

図表6：偏在対策パッケージに盛り込まれた外来医療計画強化の主な流れ

不十分な場合に対応を段階的に強化	プロセス	医療計画での対応 (医療法)	健康保険での対応 (健康保険法)
	① 協議の場での調整	➢ 都道府県が開業を希望する医師に対し、協議の場への参加を要請。 ➢ 地域で不足する機能を提供するよう要請。	➢ 保険医療機関の指定期間を6年から3年に短縮 ※3年になった場合、協議の場と医療審議会での要請。
	② 要請に沿った対応の確認	➢ 都道府県が開業した医師に対し、要請に沿った対応を取っているか確認。 ➢ 対応していない場合、医療審議会での説明を要請。	
	③ 未対応の理由の確認	➢ 未対応の理由が止むを得ないと判断できない場合、都道府県が勧告。	➢ 未対応の理由が止むを得ないと判断されない場合、名称の公表、保健所の確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付などの対応。 ➢ 勧告を踏まえつつ、未対応の場合、指定期間を再び3年に設定。
	④ 勧告に沿った対応の確認	➢ 勧告に沿って提供していない場合、公表。	➢ 未対応の理由が止むを得ないと判断されない場合、名称の公表、保健所の確認、診療報酬上の対応、補助金の不交付などの対応。

出典：厚生労働省資料を基に作成

このほか、大都市部での新規開業を希望する医師に対する規制的な手法の強化も意識された。先に触れた通り、外来医療計画では「医療提供体制改革を議論する協議の場への参加要請→席上、在宅医療など地域で不足している機能を担うことを要請→新規開業者の自主的な対応に期待→必

図表7：外来医師過多区域に指定された9つの2次医療圏

対象となる都道府県	2次医療圏の名称	対象となる市区町村
東京都	区中央部	千代田区、中央区、港区、文京区、台東区
	区南部	品川区、大田区
	区西南部	目黒区、世田谷区、渋谷区
	区西部	新宿区、中野区、杉並区
	区西北部	豊島区、北区、板橋区、練馬区
京都府	京都・乙訓	京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
大阪府	大阪市	大阪市
兵庫県	神戸	神戸市
福岡県	福岡・糸島	福岡市、糸島市

出典：厚生労働省資料を基に作成

⁹ 紹介患者の受け入れや高額な医療機器の共同利用などを通じて、身近な病気やケガに対応する中小病院や診療所を支援する病院。

要に応じて協議結果を住民などに公表」という流れが想定されているが、開業の自由との兼ね合いがあり、実効性に乏しい。

そこで、対策パッケージでは、診療所で勤務する外来医師が過剰な地域を「外来医師過多区域」に設定した上で、図表6の通り、地域で不足する医療機能を担うように繰り返し要請しても従わない場合、▽保険医療機関の指定を6年から3年に短縮、▽補助金の減額、▽診療報酬上での対応——といった条件や手続きを新たに付与することになった。さらに、その後の議論では、3度目以降は3年を2年に短縮する方針も示された。

このうち、外来医師過多区域については、「外来医師偏在指標の全国平均値＋標準偏差の1.5倍以上」「可住地面積あたり診療所数が上位10%」をともに満たす地域として、図表7の通り、東京都心部や京都市、大阪市、神戸市、福岡市に属する計9つの2次医療圏が指定された。

さらに、診療報酬での対応に関しては、2024年12月と2025年12月の予算折衝に際して、「負の動機付け」という表現で、診療報酬を減額する可能性が言及されていた。結局、2026年2月の中医協で承認された2026年度診療報酬改定では、図表6のようなルールに沿っても対応しない新規開業希望者については、「地域医療への寄与が不十分」と判断し、在宅医療を主に手掛ける診療所を評価する「在宅療養支援診療所」とか、診療所に医療・介護連携などの取り組みを促す「機能強化加算」「地域包括診療加算」「地域包括診療料」の対象から外す旨が盛り込まれた。2026年10月から対応が始まる予定となっている。

以下、新たな医師偏在対策を巡る論点として、(1) 都道府県は重点化できるのか、(2) 経済インセンティブは機能するのか、(3) 新規開業を希望する医師に対する規制的な手法は機能するのか——という3つの点で、有効性を問う。

4——新たな偏在対策は有効なのか？

1 | 新たな偏在対策の論点(1)都道府県は重点化できるのか

まず、1つ目の論点では支援区域が絡む。ここで言う支援区域のイメージとして、厚生労働省は「今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域」を挙げており、ヒトやカネなどの資源を優先的かつ重点的に投入することが意識されている。

その際には、候補として、▽都道府県の医師偏在指標が最も低い2次医療圏、▽医師少数県の医師少数区域、▽医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない2次医療圏（全国下位4分の1）——のいずれかに該当する区域を指定するとしており、最終的には都道府県が医師偏在指標、可住地面積当たり医師数、医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療の受療行動、今後の人口動態などを考慮しつつ、「地域の実情」に応じて選定するとされている。さらに、法改正に先立つ2024年度補正予算では、診療所の承継や開業に対する緊急支援が講じられており、全国で109区域が候補として指定されている。

筆者の私見として、資源と人を重点化する対応は今後、避けられないと考えている。具体的には、人口減少区域では外来機能の維持が難しくなるほか、人口密度が薄い地域では移動時間が長くなる分、訪問診療の持続も困難になる。このため、ヒトやカネなどの資源を集中する地域を絞り込むとともに、最終的に

は撤退や縮小の選択肢を模索する必要がある。

しかし、現実的な問題として、撤退や縮小の議論は難しい。例えば、都道府県が「A 区域では人口減少が著しいので、医療も介護も手を引きます」「定住が見込まれる近くの B 区域に集住して下さい」と要請しても、「居住の自由」は憲法で保障されており、実効性に乏しい。その以前の問題として、住民や市町村、地域の医師会の反発も避けられない。

このほか、医療行政のほとんどは自治事務であり、政省令に違反しない限り、自治体は独自の判断を下せる点も見逃せない。つまり、いくら国が通知やガイドラインを示しても、その法的拘束力は非常に弱く、技術的助言の位置付けに過ぎない。言い換えると、国の意向に都道府県を従わせることは困難であり、こうした状況で都道府県は少しでも多くの医師を確保するため、支援区域の対象を広げようとする可能性が高い。実際、既に青森県は全域を、秋田県は秋田市以外の県全域を支援区域に指定する方針を決めたと報じられている¹⁰。

2 | 新たな偏在対策の論点(2)経済インセンティブは機能するのか？

この論点是对策パッケージの 3 つ目、すなわち地域偏在対策における経済的インセンティブに関する部分であり、地域に医師を派遣する医療機関に対して診療報酬を加算するとともに、過疎地などで働く医師に対する手当の増額が企図されている。改正医療法の国会審議では対象者数は約 1 万人、手当の金額は 1 人当たり 4 万 3,000 円から 18 万円の間で検討するという答弁が示されている¹¹。

さらに、中堅医師に対する総合的な診療能力を学び直すための機会の提供も意識されている。つまり、大学病院などで勤務している専門医が地方勤務を希望しても、広範な住民のニーズに対応しにくいいため、全人的かつ継続的な総合診療の能力を身に付けてもらうことが重視されており、2024 年度補正予算と 2025 年度当初予算、2025 年度補正予算、2026 年度当初予算案に必要経費が盛り込まれている。

この点について、筆者は前向きに受け止めている。つまり、今までの施策では、医学を志す若手医師（しかも奨学金を必要とする若手医師）だけに偏在対策の責任を負わせていたが、中堅医師にも偏在対策の対象範囲が広がったと理解できる。さらに、医療制度改革の実行に際しては、医療機関やスタッフの収入に直結する診療報酬の誘導が最も効果的であり、偏在対策にも使われるようになった意味合いも大きい。

しかし、経済インセンティブと言っても、医師が地方勤務を決断するほどのレベルになるか微妙である。さらに、中堅医師の学び直しについても、現場の反応を聞く限り、「選択肢は広がるものの、興味を持ってくれる対象者数は限定的になる」という見方が多い。

3 | 新たな偏在対策の論点(3)～新規開業を希望する医師に対する規制的な手法は機能するのか～

第 3 の論点是对策パッケージの 4 つ目、つまり地域の医療機関の支え合いの仕組みが絡んでおり、詳細な議論に入る前に「支え合い」という言葉から検討する必要がある。

これは元々、「規制的な手法」という言葉が用いられており、厚生労働省の検討組織では、健康保険組合連合会（以下、健保連）から「国の関与と強力な規制によって過剰な開業を抑制して、実効的に医師の

¹⁰ 2025 年 10 月 31 日『m3.com』配信記事、同年 5 月 1 日『秋田魁新報』を参照。

¹¹ 2025 年 11 月 21 日、第 219 回国会衆院厚生労働委員会における厚生労働省の森光敬子医政局長の答弁。

配置転換を進めなければ、この問題は根本的に解決しないのではないか」という強硬論も出ていた¹²。要するに、外来医療計画に関連し、地域で不足する診療科あるいは医療機能を充足させる場合に限って新規開業者を保険医療機関として指定し、もし当初の約束が達成されなければ、指定を取り消す方法である。

しかし、こうした国家統制の議論は日医を刺激した。つまり、先に触れた通り、日医は伝統的にプロフェッショナル・オートノミーを重視する傾向が強く、健保連などが主張した外来医療計画の強化案に関しても、「憲法上の職業選択の自由、営業の自由との関係の整理も必要」と反論した¹³。結局、健保連などの主張は受け入れられず、「規制的な手法」という言葉も「支え合い」という文言に置き換えられた。

こうした経緯を踏まえつつ、対策の中身に目を向けると、医師少数区域での勤務経験を管理者要件とする医療機関の拡大とか、直美対策の強化など、医師の行動や判断に一定程度の縛りを掛けようとしている点で、いずれも必要性は感じるものの、どこまで偏在が解消されるか疑問と言わざるを得ない。

さらに、外来医療計画の強化に関しても、かなり無理がある運用となっている。ここでは図表6で示した部分のうち、医療法と健康保険法の関係に着目する。そもそも、医師は憲法上、どこでも開業できる「営業の自由」を有しており、国や都道府県は開業をダイレクトに規制できない。このため、どんなに外来医療計画を強化しても、都道府県は開業を制限できない。

そこで、図表6の通り、外来医療計画で規制しつつ、実効性は全て健康保険法で担保する「苦肉の策」が取られている。健康保険法であれば、国と保険医療機関の「契約」になるため、その契約を国が変更するという対応だ。

実は、こうした対策の先例として、病床過剰地域での病床規制が挙げられる。1980年代から始まった医療法に基づく都道府県の医療計画では、医療費を抑制するため、病床過剰地域でのベッドの新增設が制限されているが、これは本来、「営業の自由」に抵触する。このため、医療法と医療計画で病床数を制限するものの、病床過剰地域で新增設したベッドは健康保険法の対象としない運用となっている。言い換えると、病床過剰地域でベッドを新增設しても、医療機関は全額を自費診療で賄うことになるため、実質的に参入できないようにしている。

この苦肉の策について、制度創設時の国会では「医療法の勧告に従わなかったからという理由で、医療法ではなくて健康保険法で不利益に扱うという制度は、江戸のかたきを長崎で打つ（注：発想）」という発言も出ていた¹⁴。つまり、都道府県の医療計画では、費用を抑制するため、病床過剰地域でのベッドの新增設が制限されており、今回の偏在是正でも同様の構図になっていることに気付く。つまり、医療法に基づく外来医療計画で求めるが、強制力を持ち得ないため、実際の規制は全て健康保険法に委ねられている構造である。

しかし、こうした苦肉の策はダイレクトな規制とは言えず、どこまで効果が期待できるか流動的だ。診療報酬の加算対象としない対応についても、相当なステップを踏む制度設計になっており、適用事例は少なくなると思われる。

¹² 2024年9月30日、新たな地域医療構想等に関する検討会における健保連の河本滋史専務理事の発言。

¹³ 同上における日医の江澤和彦常任理事の発言。

¹⁴ 1998年4月14日、第142回国会衆院厚生委員会における阿部泰隆神戸大学教授の発言。なお、筆者も改正医療法の参考人質疑に招かれた際、このフレーズを使いつつ、苦肉の策の構造を指摘した。2025年12月3日、第219回国会参院厚生労働委員会議事録を参照。

4 | さらなる対策を望む声も

こうした状況を踏まえると、対策パッケージの有効性には疑問を持たざるを得ない。筆者自身としては、「開業の自由など現行制度の枠内でギリギリの対応を取った」と理解しているが、それでも有効性という点で見ると、先行きは明るいとは言えない。何よりも2040年になると、人口減少が本格化するため、既存の施策だけでは追いつかなくなる危険性が高い。

実際、議論を主導した武見氏は決着後、「もっとやればよかったと思っている。1年1カ月の在任期間では、そこまで踏み込めなかった」としつつ、後期研修医に1年間の過疎地医療に従事してもらう方策などを挙げた¹⁵ほか、東京都医師会の尾崎治夫会長も同様の考えを示している¹⁶。

しかも、外科や産科医、小児科医を中心とした診療科の偏在¹⁷、病院と診療所の偏在など別の問題も積み残されている。このため、施行後5年で予定されている見直し論議では、財務省や健保連、自治体などから規制的な手法を望む声が一層、強まる展開が予想される。

5 | 集住などの対応策も不可避？

一段と踏み込んだ対策として、条件不利地域に住んでいる住民のうち、医療や介護を要する高齢者などが近くの市街地の中心部などに集まって住んでもらう「集住」の選択肢も検討に値する。人口密度が薄い地域では、移動時間が長くなる分、訪問診療や訪問介護などが困難になるためだ。

実際、2024年12月に示された新たな地域医療構想に関する報告書でも、「人口規模の小さい地域においては、移動時間や担い手不足等の課題を踏まえ、D to P with N 等のオンライン診療の積極的な活用等に加えて、高齢者の集住等のまちづくりの取組とあわせて体制を構築していくことが求められる」という文言が盛り込まれた。

ここで言う「D to P with N」とは遠隔医療の一種であり、看護師が患者の横に詰め、オンラインで繋いだ医師とやり取りする方法であり、2024年度診療報酬改定で点数が初めて付いた。現在は離島や中山間地域を対象に、移動支援も絡めた「医療 MaaS (Mobility as a Service)」が試行されている¹⁸。2024年12月に示された新たな地域医療構想に関する報告書では、こうしたデジタル技術に集住を絡める必要性が示された形だ。

こうした考え方は現行の地域医療構想でも、一部の都道府県が示していた。例えば、北海道の地域医療構想では、病院と近接した住宅を整備した事例などを引き合いに出しつつ、「病床と自宅以外の『住まい』を確保することが必要」「広域分散型で積雪寒冷である本道においては、より一層、このような一定の集住を促進することが必要」という考え方が示されており、人口減少の加速に伴い、一部の地域で先行的に言及されていた選択肢が政府文書にも言及されるようになったと言える。

ただ、憲法で保障されている居住の自由を考えると、国や自治体が集住を強制することは不可能で

¹⁵ 2025年2月8日『東洋経済』におけるインタビューを参照。

¹⁶ 2025年12月6日に開催された日本臨床薬理学会学術総会での発言。同月8日『m3.com』配信記事を参照。

¹⁷ 2020年度から始まった医師確保計画では、現場の人材不足や偏在が著しい産科や小児科に限定する形で、診療科ごとの医師確保計画を作ることになっている。さらに、2026年度診療報酬改定では、外科医への不足に対応するため、長時間の高度な手術に関わる実施体制などを評価する「外科医療確保特別加算」が創設された。

¹⁸ 医療 MaaS については、各地の事例を紹介する『秋田魁新報』『山形新聞』『伊勢新聞』『熊本日日新聞』のほか、2024年8月号『新医療』を参照。

ある。このため、自治体が十分に説明しつつ、住民の選択肢を広げるという丁寧な対応は欠かせない。

6 | 地域医療連携推進法人の活用も必要に？

さらに、複数の医療機関が「連携以上、統合未満」で協力関係を結ぶ「地域医療連携推進法人」の活用も一つのアイデアである¹⁹。これは持株会社のような形で、複数の医療機関が病床融通や共同での物品購入、人材確保・研修、人材派遣などで協力する組織形態であり、2025年10月現在で58法人が累計で誕生している。政府としても今後の提供体制改革の柱として期待しており、経済財政の方向性を6月頃に示す「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）」には2025年版まで5年連続で言及されている²⁰。

このほか、2040年を意識した一層の対応策として、人口減少地域における地域医療連携推進法人に参画した医療機関については、診療報酬を特別に変更し、検査など治療行為ごとに評価する出来高払いではなく、地域の人口などに応じて支払う包括払いに切り替える方法も考えられる。

具体的には、身近なケガや病気に対応する開業医や中小病院に対する診療報酬は出来高払いが中心となっているが、これでは人口が減少する局面で医療機関が十分な患者と診療報酬を確保できなくなり、医療機関の縮小、撤退、廃止といった事態も懸念される。

そこで、人口が減っている地域で、かつ周辺地域の提供体制で中心的な病院や診療所については、出来高払いではなく、周辺の人口などを考慮した包括払いも検討する必要があると考えている。つまり、戦略的に撤退しつつも、守るような地域については、包括払いを導入することで、収入を固定化させるという趣旨である。

その際には、[\(上\)](#)で詳述した新たな地域医療構想や高齢者の集住、医師偏在対策の強化、地域医療連携推進法人、オンライン診療などを絡めつつ、都道府県や市町村が「地域の実情」に沿った体制整備に努める必要がある²¹。

実際、この動きは介護で先行し始めた。具体的には、3年に一度の制度改正に向けて、社会保障審議会介護保険部会が2025年12月に示した報告書では、中山間・人口減少地域における事業所の経営を安定化させるため、訪問回数を中心とした出来高払いの報酬体系ではなく、月単位の定額払いなど包括払いの導入が言及された²²。筆者自身としては、医療でも同様の制度を将来的に検討する必要があると考えている²³。

¹⁹ 地域医療連携推進法人の経緯や動向については、2025年10月28日拙稿「[地域医療連携推進法人の現状と今後を考える](#)」を参照。

²⁰ ただし、2024年12月に示された「総合的な改革意見」には地域医療連携推進法人は言及されていない。

²¹ 近年、厚生労働省の審議会文書では「地域の実情」が多用されており、この言葉に着目しつつ、自治体に求められる対応などを取り上げたコラムを2023年3月から2025年3月まで計7回連載した（うち1回は番外編）。全7回の内容などについては、[リンク先](#)の一覧を参照。

²² 2040年を意識した介護保険改正の動向については、2026年2月18日拙稿「[昨年末に示された介護と福祉の部会意見書を読み解く（上）](#)」を参照。厚生労働省は今後、2027年度報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会で検討を深めるとしている。

²³ ただ、医療と介護の違いなど詰めなければならない論点が多い。例えば、医療の診療報酬は「1点＝10円」の全国一律だが、介護では地域ごとに物価を考慮する「地域区分」が採用されており、全国一律ではない。医療に関しても、都道府県の判断で単価などを変更できる「地域別診療報酬制度」が導入されているものの、医療費適正化に繋がるとして、日医が実施に強く反対している。さらに、注意を要するのは包括払いのマイナス面である。つまり、包括払いの下では、医療提供者は治療・検査などを実施しても、実施しなくても報酬が変わらなくなるため、必要な治療が実施されない「過少診療」が起き

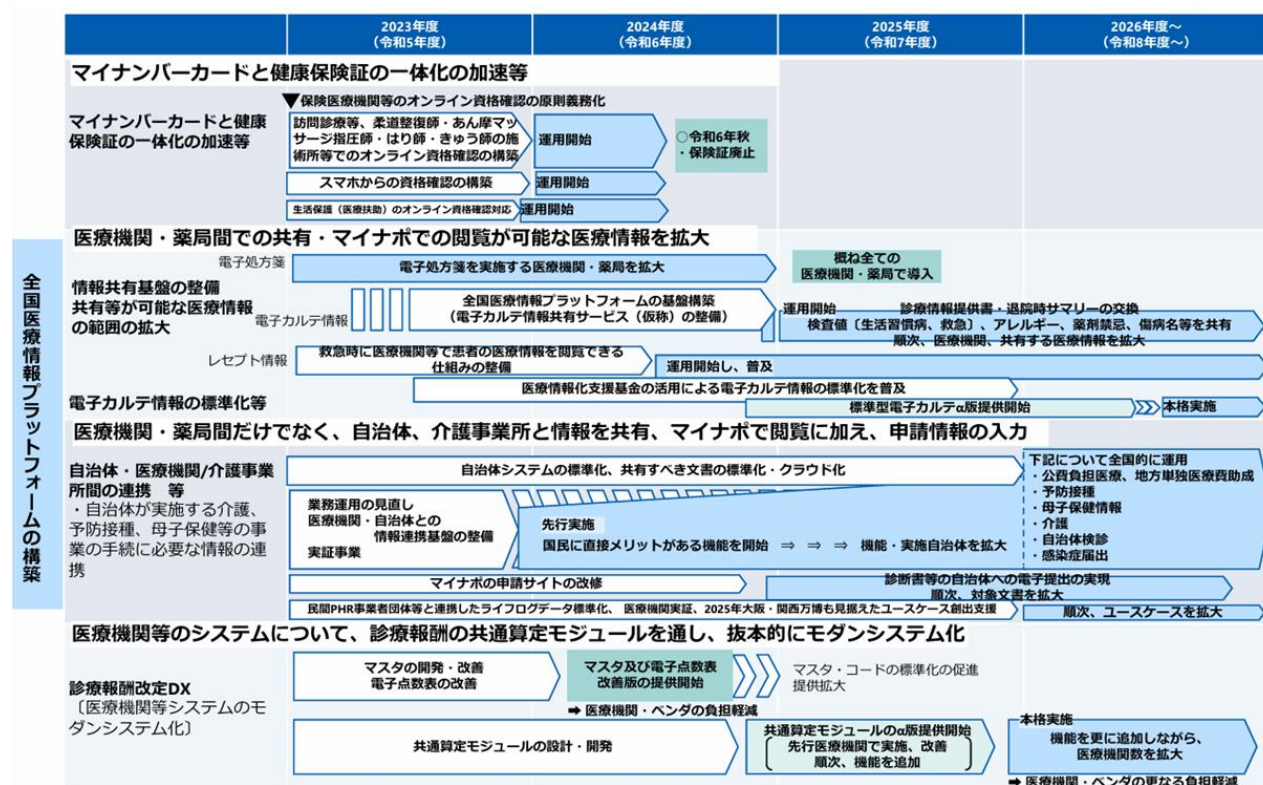
次に、改正医療法の3つ目の論点である医療DXを取り上げる。具体的には、(1) 電子カルテの普及、(2) 健康保険組合などのレセプトを審査する社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）の大幅な改組——を取り上げる。さらに、図表1で掲げた改正医療法の概要資料では「地域医療構想の見直し等」に入っているが、3つ目の論点として、オンライン診療の法的位置付けの明確化も検討する。

5——医療DXの推進

1 | 医療DX 令和ビジョン2030の内容

医療DXの方向性については、自民党が2022年5月に取りまとめた「医療DX 令和ビジョン2030」に触れる必要がある。ここでは、電子カルテの標準化と共有に加えて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化による資格確認（いわゆるマイナ保険証）を含めて、医療機関や介護事業者、行政機関の情報を連携・共有する「全国医療情報プラットフォーム」の構築、診療報酬に関する業務のデジタル化・効率化を目指す「診療報酬DX」などが盛り込まれていた。

図表8：医療DXの推進に関する工程表（全体像）



出典：厚生労働省資料から抜粋

これを受けて、厚生労働省は2022年9月、関係部局の幹部で構成する「医療DX 令和ビジョン2030」厚生労働省推進チームを発足させ、図表8の通り、2023年6月に「医療DXの推進に関する工程表（全体像）」が決定された。工程表では、▽マイナンバーカードと健康保険証の一体化、▽医療機関・薬局

るリスクは起こり得る。そこで、一部で出来高払いを絡めたり、成果（アウトカム）で支払う成績払いを採用したりする必要もある。このほか、医療行政を現場で司る都道府県などとの関係も論点になる。

での共有、マイナポータルで閲覧が可能な医療情報の対象拡大、▽自治体や介護事業所との情報共有、▽診療報酬の共通算定モジュールを通じた抜本改革——といった見直しを通じて、全国医療情報プラットフォームを構築するとともに、電子カルテの標準化などにも取り組むとしている。さらに、2026年度までに展開する必要な施策と時期も明示された。

2 | 支払基金の大幅な改組

こうした経緯を踏まえ、改正医療法では支払基金の大幅な改組が盛り込まれた。つまり、支払基金を審査業務だけでなく、レセプトデータなど医療 DX の拠点として位置付ける改革であり、国の関与を強化するとともに、名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改めることが決まった。

元々、支払基金については、都道府県単位で審査ルールが異なる点が問題視されていた。つまり、保険診療のルールは全国統一なのに、審査に関しては支部別の差異が見られた。そこで、支部間でレセプトを交換して審査する「実験」も試みられたことがあった²⁴。結局、2016年6月と2018年6月の規制改革実施計画では、審査業務の効率化や審査基準の統一化、ビッグデータの活用、支部の集約化などが規定された。その後、2019年5月の支払基金法改正を経て、都道府県単位の支部はブロック単位に改組されるに至った。さらに、人工知能（AI）も含めたデジタル技術の活用を通じて、不合理な地域差の解消が目指されている。

今回の法改正では一層の改革が志向されており、厚生労働相が医療 DX の総合的な方針を定めるとともに、支払基金は医療 DX の中期的な計画を定め、厚生労働相の認可を受けることになった。

さらに、支払基金の組織も大幅に変更され、医療 DX に関しては、保険者（保険制度の運営者）、被保険者、診療側、有識者の4者構成16人の理事会に代わり、自治体の代表などを交えた運営会議を設置し、この会議体が理事長など役員の選任、予算・決算の作成・変更、定款・事業計画の作成・変更、医療 DX に関する中期計画の策定などを担うことになった。このほか、情報通信技術に関する高度かつ専門的な知識を有する専門家を理事（CIO、最高情報責任者）として選任することも決まった。

一方、審査支払業務については、審査支払に関する予算・決算や事業計画などを担当する委員会を設置し、これまでと同様に4者構成16人の体制で運営することになった。

要は支払基金の業務として医療 DX の推進が明確に位置付けられるとともに、国のガバナンスを含めた責任体制が強化されたと言える。さらに、自治体代表を交える部分については、以前から懸案となっているレセプトを巡る「分断」構造の解消という意図もありそうだ。つまり、自営業者や高齢者など国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入する人や家族のレセプトは都道府県単位に設置された国民健康保険連合会で審査されており、以前から両者の関係性が論点になっていた。今回、運営会議に自治体の代表も入ることで、データ活用の部分では今まで手付かずだった自治体行政や国民健康保険などとの連携が意識されたと言える。

3 | 電子カルテの拡大

電子カルテの拡大は国会審議に先立つ政党間協議で焦点になった。具体的には、[\(上\)](#)で述べた通り、

²⁴ 「実験」的な取り組みの開始については、中村秀一（2019）『平成の社会保障』pp366-367を参照。

改正医療法に関して、当時の与党だった自民党と公明党は衆院で過半数を割っていたため、日本維新の会（以下、維新）との連携を強め、早期成立を目指した。

結局、成立は2025年臨時国会にずれ込んだが、2025年6月の3党合意では（中）で触れた新たな地域医療構想の病床削減に加えて、本稿のテーマである電子カルテについても、「現時点の電子カルテ普及率が約50%であることに鑑み、普及率約100%を達成するべく、5年以内の実質的な実現を見据え電子カルテを含む医療機関の電子化を実現する」「医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子カルテを通じた医療情報の社会保険診療報酬支払基金に対する電磁的提供を実現する」という文言が盛り込まれた。

さらに、（上）でも論じた通り、臨時国会の衆院における修正協議では、2030年12月までに電子カルテの普及率を約100パーセントに引き上げることで、医療機関の電子化を実現することを政府に義務付ける規定が追加された。

しかし、3党協議では温度差が見られるのも事実である。協議に加わった維新の阿部圭史衆院議員は医療制度の効率化を重視する観点に立ち、100%という数値を「達成しなければならない目標」と強調。その上で、ステップ1として診療所、病院を問わず、電子カルテシステムを導入し、ステップ2として医療機関同士、あるいは支払基金と電磁的に医療情報を共有する体制を整えることが重要と訴えている²⁵。

これに対し、同じく協議に参画した自民党の国光あやの衆院議員は費用面でのハードルに加えて、高齢の医師が対応しにくいという心理面の問題を挙げつつ、『100%』にこだわるのはなかなか難しい」と述べている。その上で、標準型電子カルテの開発・推進や病院規模別の電子カルテ価格帯の目安の設定などが必要と訴えている²⁶。

このほか、電子カルテの100%という目標の関係では、日医も慎重な姿勢を示している。つまり、「導入不可能」と答えた医師が半数以上に及んだ日医の会員向けアンケート調査などを引き合いに出しつつ、「医療従事者も、患者も対応できない方がいる。混乱と支障がないような丁寧な進め方をお願いしたい」「電カル廃業（筆者注：電子カルテ義務化を理由にした廃業を指す）に追い込まれないようにいろいろな手当てをお願いしたい」という見解である²⁷。

要するに、維新が主張する通り、電子カルテ100%という手法を急ぐと、それを理由にした廃業を誘発し、偏在が進む危険性が高まるため、一種のトレードオフの関係になっている。こうした中、上野賢一郎厚生労働相は2026年1月、電子カルテなどの具体的な普及計画について、「2026年夏までに取りまとめた」と述べており、今後は100%の数値目標の是非と実現策が論点になりそうだ。

4 | オンライン診療の法的な位置付けの明確化

第3に、オンライン診療について、医療法での位置付けが明確化された。ここで簡単にオンライン診療の歴史を振り返ると、2018年度改正で初めて本格的に保険給付の対象となり、2020年2月頃から

²⁵ 2025年6月20日『m3.com』配信記事を参照。

²⁶ 2025年6月25日『m3.com』配信記事を参照。

²⁷ 2025年12月3日、第219回国会参院厚生労働委員会における日医の城守国斗常任理事の発言。

²⁸ 2026年1月9日に開催された四病院団体協議会の新年会員交流会での発言。同月10日『m3.com』配信記事を参照。

新型コロナウイルスの拡大で脚光を浴びるに至った。特に、オンライン診療を利用できる患者について、医師が初診を対面で診察したケースに限る「初診対面原則」の是非が焦点となり、コロナ対応では2020年4月から初診対面原則が廃止されたほか、2022年度診療報酬改定では全てのケースでも初診対面原則が撤廃された²⁹。

こうした中、一層の拡大を目指す観点に立ち、政府の規制改革推進会議が2023年11月、公民館や通所介護（デイサービス）事業所での実施が可能となるように要請していた。さらに、これまでのオンライン診療は法令の解釈運用にとどまるなど、制度上の不備も多かった。

そこで、社会保障審議会医療部会が2024年12月に示した総合的な改革意見では、医療法でオンライン診療を定義する必要性とともに、▽オンライン診療を手掛ける医療機関は所在地の都道府県知事に届け出ることを義務化、▽現行のオンライン指針の内容を基に、厚生労働相がオンライン診療を行う医療機関の管理者が講じるべき措置を基準に明記、▽オンライン診療を実施する医療機関の管理者は当該基準を遵守することを義務化、▽オンライン診療の受診の場を定義し、場を設置する者は所在地の都道府県知事に届け出る、▽オンライン診療の受診の場を設置する者は必要な事項を公表——などが言及された。

その後、中医協や医療部会などでの検討を経て、制度設計の詳細が決まった。具体的には、現在の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に代わり、厚生労働相が「オンライン診療の適切な実施に関する基準」を策定することで、法的な位置付けを明確にすることになった。さらに、自由診療を含めて、不適切な事例が発生した場合、都道府県が指導や立ち入り検査などを実施することも決まった。

このほか、従来は診療所の設置などの手続きが必要だったが、受診の場として、「オンライン診療受診施設」という枠組みが作られることになった。これは「業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」という定義であり、公民館や郵便局、職場、介護事業所、保険薬局などが想定されている³⁰ほか、▽営利法人による設置、▽医業広告と同様の広告——なども認められた。

以上のような経過や内容を踏まえると、今回の法改正を通じて、オンライン診療の法的な位置付けやルールが明確になったことで、自由診療も含めて、運用の透明性が高まったと言える。実際、厚生労働省は「改正医療法の施行に伴い、まずはどこの医療機関がオンライン診療を手掛けているのか届け出を求める。その上で規定に照らして不適切な事例が認められた場合には、行政がしっかりと指導できるという枠組みを作る」と説明している³¹。

さらに、受診できる場も広がることで、患者にとっての利便性向上も期待できる。確かにオンライ

²⁹ オンライン診療に関しては、2022年5月16日拙稿「[2022年度診療報酬改定を読み解く（上）](#)」、2021年12月28日拙稿「[オンライン診療の特例恒久化に向けた動向と論点](#)」、2020年6月5日拙稿「[オンライン診療を巡る議論を問い直す](#)」を参照。

³⁰ ここでは詳しく述べないが、保険薬局の指定については、医師と薬剤師の業務を区分する「医薬分業」の考え方に抵触するとして、保険薬局とオンライン診療受診施設の一体的な構造・経営が禁止された。

³¹ 2026年1月26日、医療部会における厚生労働省の森光医政局長の発言。同年1月30日『日経メディカル』配信記事を参照。

ン診療では触診ができない点など不十分な面もあるが、「距離」の壁を越えられるメリットがあり、都道府県や市町村は先に触れた医師偏在是正対策を総合的に進めるため、オンライン診療や医療 MaaS を活用することが一層、求められる。

その半面、営利法人を含めて幅広い主体の参入を認めたことで、行き過ぎた営利主義などのマイナス面も懸念されるため、厚生労働省や都道府県は適切な運用を促す必要がある。

6——美容整形の規制強化

最後に、改正医療法では美容整形に関する内容も盛り込まれていたもので、簡単に言及する。この関係では、厚生労働省が 2024 年 6 月、日医幹部や有識者などで構成する「美容医療の適切な実施に関する検討会」を発足させ、同年 11 月に報告書が取りまとめられた。

図表9：美容医療の適切な実施に関する報告書の概要

美容医療の適切な実施に関する検討会 報告書（概要）	
1. 適切な美容医療が安全に提供されるようにするための対応策	
● 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入	美容医療を提供する医療機関の管理者を対象として、当該医療機関における 安全管理措置の実施状況、医師の専門医資格の有無、合併症や後遺症等の問題が起きた場合に患者が相談できる連絡先等 について、 定期的（年に1回）な報告 を求めることとし、また、その報告内容のうち患者が相談できる連絡先など必要な内容を、 都道府県等において公表
● 保健所等による立入検査や指導のプロセス・法的根拠の明確化	厚生労働省において、医師法や保険看法等への違反疑いのある事例に対する医療法に基づく 保健所等の立入検査等の可否・法的根拠や、立入検査の実施プロセス、調査の観点について明確化 を行い、解釈通知を发出
● 診療録等への記載の徹底	診療録の記載事項について、各診療の実態を確認するために 必要な内容を記載
● オンライン診療のルールの整理	厚生労働省において、 オンライン診療指針が厳格に遵守 されるよう、その法的な位置づけを整理
2. 美容医療の質をより高め、質の高い医療機関が患者に選ばれるようにするための対応策	
● 関係学会によるガイドライン策定	以下の内容を盛り込んだガイドラインを複数の関係学会、日本医師会や日本歯科医師会等の団体が主体的に策定。 ・医事法制（医師法、保険看法、医療法等）や消費者保護法制等の 遵守すべき関係法令の内容、明確な解釈 ・標準的な 治療内容・手技 、医療機関の医師数や 経歴・専門性、合併症や後遺症等に関するリスク の説明方法等 ・診療に関する 記録として残しておくべき事項やその記載方法 （患者の要望・同意内容、提案・説明内容、手術・投薬等の内容・結果等） ・ 有害事象発生時の対応 （アフターケア、医療機関との連携、急変時の体制の構築等） ・ 経験・年次・専門性等に応じた治療の実施や、研修制度 、指導担当医師による 教育システム 等 ・ 契約締結時の遵守すべきルール （契約書面に記載すべき内容、医師の説明内容、いわゆるカウンセラーとの役割分担、即日治療の原則禁止等）
● 医療広告規制の取締り強化	・ 医療広告のネットパトロールを強化し 、違法な広告により患者が医療機関に誘引されないように取り組む
● 行政等による周知・広報を通じた国民の理解の促進等	患者が美容医療の特徴やリスクを正しく理解し医療を選択できるよう、 患者に対し以下のような周知・広報 を実施 ・美容医療に関する 医事法制 （いわゆるカウンセラーによる治療内容の決定の違法性等） ・美容医療に関する 消費者保護法制 （契約の中途解約やクーリング・オフ制度、書面交付義務等） ・美容医療において 発生しうる問題事例やリスク （副作用や合併症・後遺症、契約トラブル等） ・美容医療の トラブルに係る相談窓口

出典：厚生労働省資料から抜粋

ここでは図表 9 の通り、安全管理の対応や専門医資格の有無、後遺症の問題が起きた時の相談対応などについて、美容医療を手掛ける医療機関に対し、1 年に 1 回の定期的な報告を求めるとともに、都道府県で公表する方向性が盛り込まれた。

厚生労働省は報告制度を通じて、「都道府県等が医療機関の安全確保措置等の実施状況を網羅的、定期的に把握することが可能」になると強調するとともに、有害事象が疑われる場合などには立入検査

なども実施できるとし、美容医療の透明性が高まるとしている³²。

7—おわりに

本稿では、2025 年 12 月に成立した改正医療法のうち、医師偏在対策や医療 DX に関わる部分を中心に論じた。このうち、医師偏在対策ではクリアカットな解決策は存在しないため、今回の法改正に沿って、地域枠の拡充に限らず、支援区域で勤務する医師への経済的なインセンティブの付与など可能な範囲を積み上げる必要がある。

しかし、それだけで十分とは言えず、一層の対策を求める声が強まる可能性が高い。その際には(上)(中)で言及した新たな地域医療構想や地域医療連携推進法人などを意識しつつ、都道府県が「地域の実情」に応じた体制整備に取り組む必要が高まる。

後半に述べた医療 DX では、電子カルテの普及や支払基金の大幅な改組、オンライン診療の法的な位置付けの明確化などに触れた。特に電子カルテについては、100%化を急ぐと、高齢の開業医を中心に廃業が増え、医師の偏在を加速させる危険性もあり、現場に対する支援策などが論点になりそうだ。

※ 2026 年 2 月末時点の情報を基にしています。

³² 2025 年 11 月 21 日、第 219 回国会衆院厚生労働委員会における厚生労働省の森光医政局長の発言を参照。